

УДК: 616.5-006.6-076.4

Л.Ж.Беламанова

Региональный диагностический центр

Роль субоперационного цитологического метода исследования абластичности при новообразованиях КОЖИ

Аннотация. Проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования 40 больных с новообразованиями кожи. Показано, что результаты цитологического исследования определяют дальнейшую тактику лечения в зависимости от абластичности операционной раны.

Ключевые слова: новообразования кожи, цитологический метод.

Злокачественные новообразования кожи являются одним из наиболее частых онкологических заболеваний, а в некоторых странах они занимают первое место. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50% (Арзыкулов Ж.А. и соавт., 2007) [1].

Несмотря на наружную локализацию рака кожи и доступность опухоли для исследования, до настоящего времени нередко встречаются распространенные, запущенные формы заболевания, лечение которых является сложным и не всегда приводит к удовлетворительным результатам. Лечение данных форм рака кожи нередко представляет значительные трудности, особенно при локализации заболевания в области головы и лица (Пустынский И.Н. и др., 2002; Демидов Л.В. и др., 2004) [2,3]. Несмотря на то, что с момента первого иссечения рака кожи прошло более 140 лет, до настоящего времени нет единого мнения об адекватных границах иссечения рака кожи, т.е. о необходимом объеме удаляемых вместе с опухолью видимо здоровых тканей. Как правило, лечащему врачу ничего неизвестно о глубине инвазии, что и предопределяет возникновение рецидива. В связи с этим, важно разработать детальный план хирургического лечения, чтобы максимально предупредить возникновение продолженного роста и рецидива (Ахметов И.Р. и др., 2006; Лемехов В.Г., 2001; Михнин А.Е., 2001; Барчук А.С., 2001) [4,5,6,7].

В настоящее время вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в практической деятельности не вызывает сомнений. Во время операций очень часто возникают трудности при решении вопроса о степени распространенности рака, абластичности и радикальности проведенного оперативного вмешательства (Максимова Н.Е. и др., 1999; Савельев А.Е. и др., 2003) [8,9]. В связи с вышеизложенным важную роль в улучшении хирургического лечения рака кожи можно достичь, используя экспресс-цитологический метод исследования краев послеоперационной раны.

Цель

- определить ценность цитологической диагностики при срочных исследованиях с краев послеоперационной раны при новообразованиях кожи.

Материалы и методы исследования

Проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Из 40 больных установлены цитологически следующие варианты: плоскоклеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%). В дальнейшем все они получили гистологическое подтверждение. Цитологические препараты окрашивали по Паппенгейму.

Результаты и обсуждение

Цитологически плоскоклеточный рак характеризовался полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. При этом клетки округлые, овальные, полигональные, лентовидные, веретенообразные. Ядра клеток округлые или овальные, полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Увеличенные ядрышки определялись в единичных относительно светлых клетках. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная или слегка зернистая.

Клетки располагались разрозненно, группами комплексами. В большинстве комплексов, особенно крупных, клетки имели хорошо различимые межклеточные мостики. Фон мазков был представлен, в основном, элементами выраженной воспалительной инфильтрации. Так выглядел плоскоклеточный ороговевающий рак кожи (рисунок 1).

Цитологическая картина плоскоклеточного неороговевающего рака была представлена клетками опухоли с выраженными признаками анаплазии. Клетки крупных размеров, в основном, неправильной округлой формы. Ядра клеток очень крупные, с неровными конту-

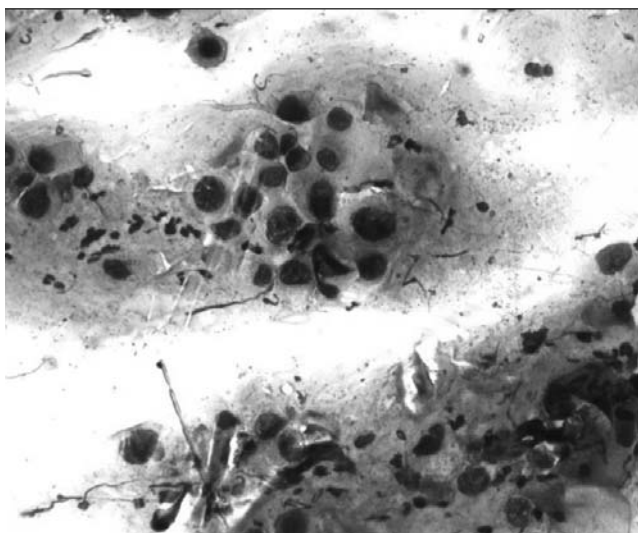


Рисунок 1 – Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

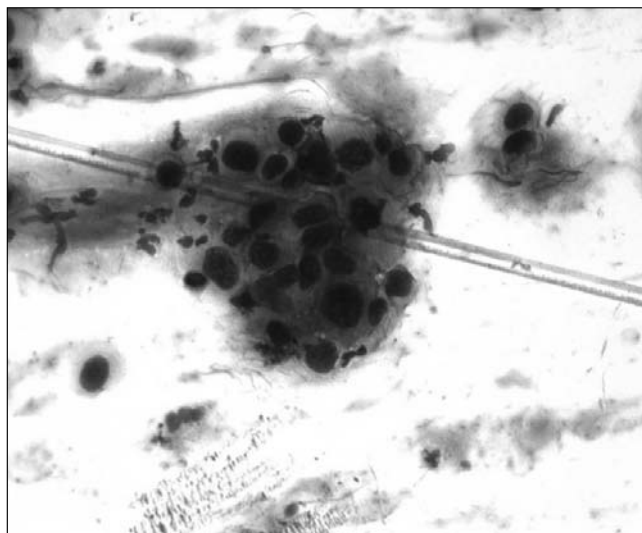


Рисунок 2 – Плоскоклеточный неороговевающий рак кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

рами, светлые. Хроматин тяжистый, распределялся неравномерно, иногда в виде глыбок черного цвета. В ядрах часто определялись 1-2 крупных неправильной формы ядрышка. Хроматин тяжистый, распределен неравномерно. Цитоплазма клеток обильная, от светло-голубого до ярко-синего цвета, гомогенная, иногда без четких границ, как бы сливается с общим фоном мазка (рисунок 2).

Для цитогрaмм базалиом было характерно наличие плотных тканевых клочков, тяжей а также трабекулярных, солидных структур, комплексов и полей с фестончатыми краями. Клетки в комплексах и тяжах базалиомы были различной величины и формы, но преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой. Ядра были невелики по размерам, округлой, овальной или вытянутой формы, гиперхромно и диффузно окрашенные, так что структуры хроматина и ядрышки незаметны. Хроматин ядер грубоглыбчатый. Цитоплазма клеток скудная и негомогенная. Иногда ядра приобретали веретенообразную форму, слегка напоминая фибробласты. Помимо мелких гиперхромных клеток встречались более светлые клетки среднего размера, округлой или полигональной формы с центрально расположенными ядрами, напоминающими

клетки плоскоклеточного рака.

В препаратах много элементов воспаления — лейкоцитов, гистиоцитов (рисунок 3,4).

При меланоме кожи цитологическая картина была крупными клетками округлой, неправильной формы. В клетках обнаруживался пигмент меланин, который, заполняя всю клетку, придавал ей вид кляксы. В отдельных клетках пигмент в виде пылевидной зернистости равномерно заполнял цитоплазму и придавал ей серовато-зеленоватый оттенок. Ядра клеток полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Хроматин ядер мелкоглыбчатый, окрашен гиперхромно. Цитоплазма клеток базофильная. В зависимости от содержания пигмента цвет ее варьировал от аспидно-серого до черноватого. Встречались резко полиморфные двуждерные клетки (рисунок 5,6).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом в мазках-отпечатках с краев, дна раны и с поверхности опухоли у 12 больных были выявлены опухолевые клетки.

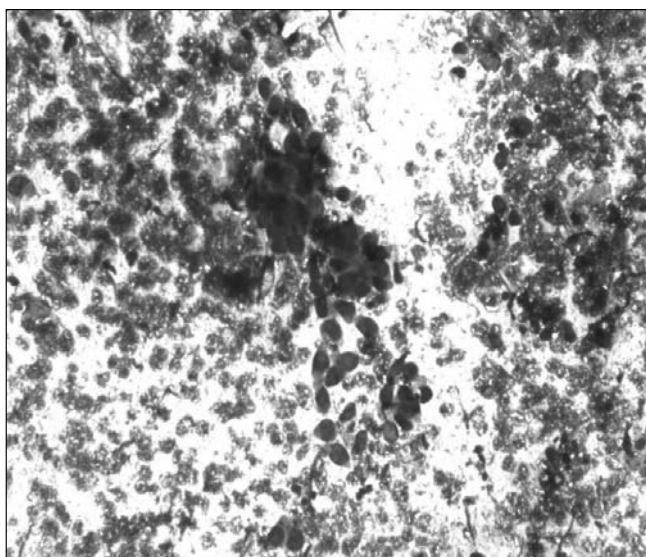


Рисунок 3 – Базалиома.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

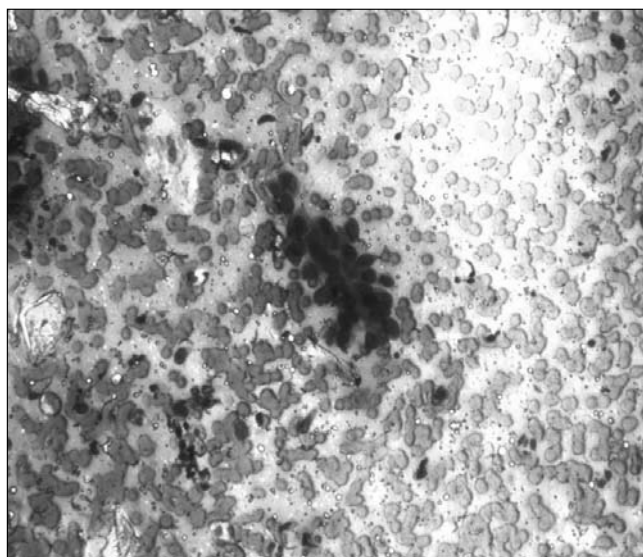


Рисунок 4 – Базалиома.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

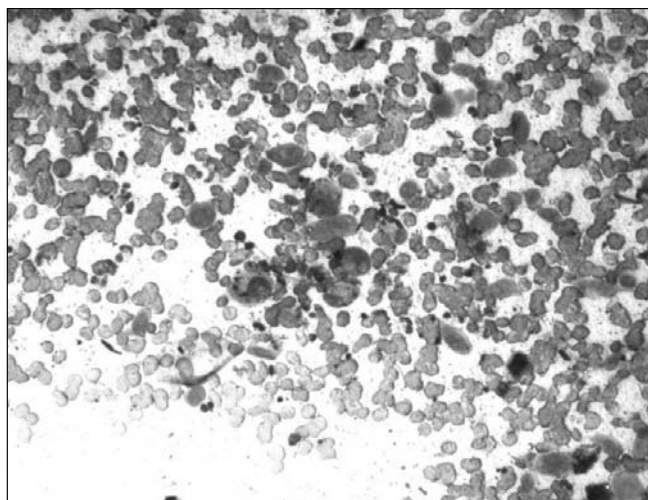


Рисунок 5 – Меланома кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

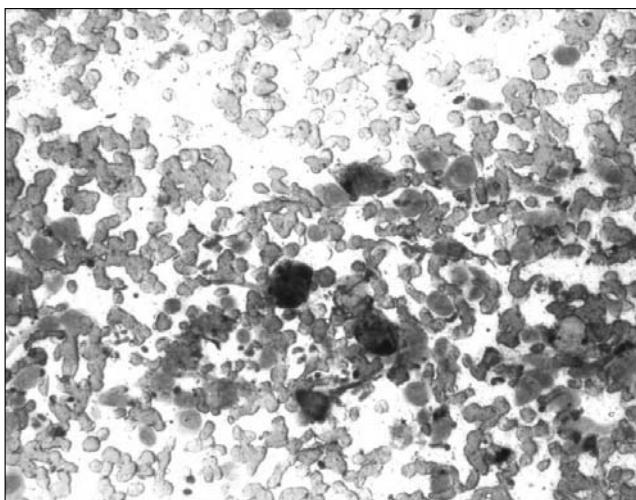


Рисунок 6 – Меланома кожи. Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

Из 12 больных в 8 случаях (66,7%) при цитологическом исследовании картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, однородная или слегка зернистая. Клетки располагались разрозненно, группами комплексами. Данная цитограмма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки. Ядра небольшие, округлой, овальной и вытянутой формы, гиперхромно и диффузно окрашенные. Хроматин ядер грубоглыбчатый. Цитоплазма клеток скудная и неомогенная.

У одного пациента (8,3%) злокачественные клетки обнаруживались со дна послеоперационной раны, которые были представлены крупными клетками округлой, неправильной формы. В единичных клетках определялся пигмент. Ядра клеток были полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная. Встречались резко полиморфные двуклеточные клетки. Данная картина была характерна для меланомы.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток.

В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Таким образом, правильная цитологическая диагностика гистогенеза опухолей кожи имеет определяющую роль в выборе тактики лечения. Кроме того, применение субоперационного цитологического исследования на абластичность из краев резекции позволяет провести дальнейшую корригирующую терапию опухолей кожи.

Список литературы

1. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году (статистические материалы). - Алматы, 2007. - 52с.
2. Пустынский И.Н., Шенталь В.В., Пачес А.С. и др. Клинико-морфологические особенности распространенных форм рака кожи // Мат. VI Российской онкологической конф. - М., 2002.
3. Демидов Л.В., Алиев М.Д., Мартынова Е.В. и др. Прогностические факторы в оценке первичной меланомы кожи и их значение для выбора объема оперативного вмешательства // Мат. VIII Российского онкологического конгресса. - М., 2004.
4. Ахметов И.Р., Важенин А.В., Привалов А.В., Анищенко И.С. Меланома кожи: тактика хирургического лечения в отношении регионарных лимфатических узлов (обзор литературы) // Сибирский онкологический журнал. - 2006. - Т.19, №3. - С.68-72.
5. Лемехов В.Т. Эпидемиология, факторы риска, скрининг меланомы кожи // Практическая онкология. - 2001. - Т.8, №4. - С.3-11.
6. Михнин А.Е. Злокачественная меланома кожи: поиски стандартов лечения // Практическая онкология. - 2001. - Т.8, №3. - С.69-72.
7. Барчук А.С. Хирургическое лечение меланом // Практическая онкология. - 2001. - Т.№8, № 4. - С.30-36.
8. Максимова Н.Е., Шабанов А.М. Прогнозирование частоты базалиом. Актуальные проблемы пато- и морфогенеза. Системные аспекты патологии и вопросы преподавания патологической анатомии // Сб. трудов науч. конф., посвященной 100-летию каф. патол. анатомии С-Петерб. гос. мед. ун-в. им. И.П. Павлова. - СПб., 1999. - С.46-47.
9. Савельева А.Е., Ковалев Ю.Н., Важенин Д.В. Факторы риска развития рецидивов базально-клеточного рака кожи лица // Сибирский онкологический журнал. - 2003. - Т.2, №18. - С.14-16.

Тұжырым

Л.Ж.Беламанова

Жергілікті диагностикалық орталығы

Операция үстіндегі абластикалық зерттеудің цитологиялық әдісінің терісінің ісігі кезінде қолданылуы

Тері ісігімен ауырған 40 аурудың интраоперациялық экспресс-цитологиялық әдісі зерттеуінің нәтижелері анализ жасалынған. Цитологиялық зерттеудің нәтижелері емдеудің одан әрі тактикасын амал жарақатынаң абластикадан анықтайды.

Түйінді сөздері: экспресс-цитология, абластика, терінің ісігі

Summary

L.Zh.Belamanova

Regional Diagnostic Centre

Role of cytology method researching ablastica during the surgery with skin tumors

40 patients' with skin tumor intraoperative express

cytology method results were analyzed. Results of cytology research define further treatment according to ablastica of surgery injury.

Key words: express-cytology, ablastica, skin tumor